Ces notes ont pour seule vocation d'être utilisées par les étudiants dans le cadre de leur cursus au sein de l'ULiège.

Aucun autre usage ni diffusion n'est autorisé, sous peine de constituer une violation de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur.

1

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Professeure G. SCANTAMBURLO

2

G. Scantamburlo - ULiège

Fondation Pierre DENIKER

3

1% DE LA POPULATION EST TOUCHEE PAR LA **SCHIZOPHRENIE** [1]

75% DES TROUBLES LIES A LA LA SCHIZOPHRENIE SE DECLARENT **AVANT L'AGE DE 25 ANS** [2]

LES PERSONNES ATTEINTES DE SCHIZOPHRENIE SONT **7 FOIS PLUS** VICTIMES D'AGRESSIONS QUE LA POPULATION GENERALE [3]

SOURCES :
[1] et [2] Chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
[3] Rapport la Haute Autorité de Santé paru 7 juillet 2011.

Objectif : un autre regard sur la schizophrénie.

Tout le monde se fait de fausses idées sur cette maladie, particulièrement méconnue.

- **L'inclusion est possible :** soignés et accompagnée, les patients ne sont plus enfermés dans la maladie. Ils peuvent construire un projet de vie.
- **Il ne faut plus en avoir peur**, il faut briser les clichés.

La campagne a pour objectifs :

- **de faire changer le regard sur la schizophrénie**
- **d'informer sur les avancées des soins :** avec de nouvelles prises en charge, les personnes vivant avec une schizophrénie peuvent maintenant avoir de l'espoir.
- **de collecter des fonds pour la recherche scientifique**, afin de confirmer les pistes pour

Cette campagne est l'occasion de soutenir la recherche et le soin avec la Fondation Pierre Deniker.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur **fondationpierredeniker.org/une-autre-realite**

G. Scantamburlo - ULiège

4

SCHIZOPHRENIES

Introduction

Prévalence vie entière: 0,7 à 1 %
Pic d'incidence: 18 à 25 ans
Répartition homogène

Schizophrénies: aspects clés

Idées délirantes
Hallucinations
Parole désorganisée
Comportements désorganisés
Symptômes négatifs

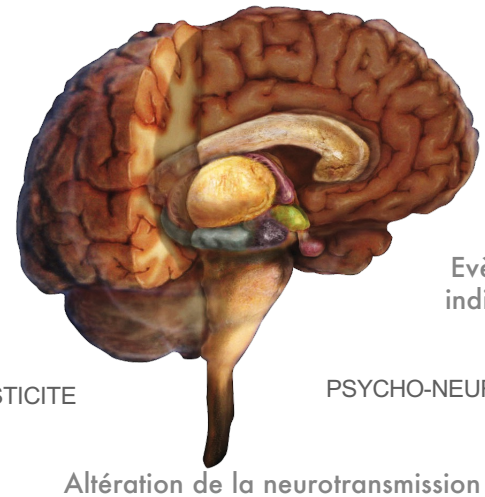
G. Scantamburlo - ULiège

5

Troubles psychotiques: facteurs de risques

Complications obstétricales
Traumas précoces
Urbanisation
Age élevé du père
Cannabis
Migration

Facteurs génétiques



Stresseurs
Evènements, situations, individus, commentaires

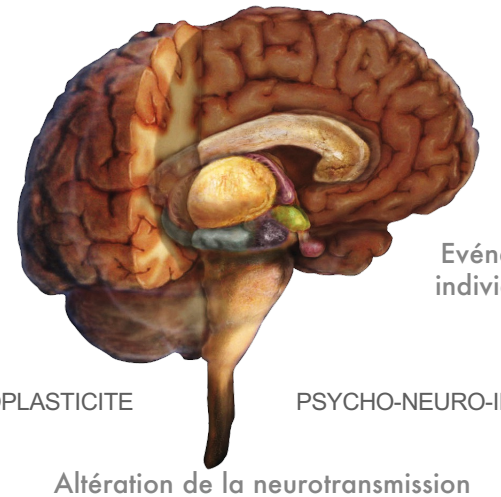
NEUROPLASTICITE

PSYCHO-NEURO-IMMUNOLOGIE

Altération de la neurotransmission et de l'immunité

G. Scantamburlo - ULiège

6



7

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Objectifs pédagogiques

- Connaître les données épidémiologiques
- Reconnaître un syndrome positif, un syndrome négatif et un syndrome de désorganisation, et les diagnostics différentiels, psychiatriques et non-psychiatriques
- Dresser les possibilités thérapeutiques en lien avec la physiopathologie et des conseils pratiques à donner au patient
- Citer les mécanismes d'action des psychotropes, les principales molécules utilisées et leurs effets indésirables
- Connaître les principales interactions médicamenteuses

8

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome positif

- Idées délirantes (90 %)
  - altération du contenu de la pensée entraînant une perte de contact avec la réalité
  - conviction inébranlable, inaccessible au raisonnement ou à la contestation des faits
  - « évidence interne », qui n'est généralement pas partagée par le groupe socio-culturel
- Hallucinations

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome positif

- Idées délirantes
  - thème: sujet principal sur lequel porte l'idée
  - mécanisme: processus par lequel l'idée délirante s'établit
  - systématisation: organisation et cohérence des idées délirantes
  - adhésion: degré de conviction attaché à ces idées
  - retentissement émotionnel et comportemental

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Thèmes délirants les plus fréquents

Nom du thème	Définition	Exemple
Persécution	Idée délirante dans laquelle le thème central consiste pour le sujet à être attaqué, harcelé, trompé, espionné, persécuté ou victime d'une conspiration	« Je sais bien que vous mettez des médicaments dans mon pain pour que je me taise et que je ne révèle pas au monde le soulèvement populaire communiste qui est en train de se préparer. »
Grandeur/ mégalomaniaque	Idée délirante qui implique de la part du sujet un sentiment exagéré de son importance, de son pouvoir, de son savoir, de son identité	« Vous voulez me faire une prise de sang pour le revendre. Mais je suis votre directeur et votre roi, je refuse que vous preniez mon sang. »
Mystique	Idée délirante dont le thème central est la religion	« Je sais que je suis le fils préféré de Dieu, et qu'il m'a confié un rôle spécial sur Terre. »
Somatique	Idée délirante dans laquelle le thème central touche au fonctionnement du corps	« Je sens mauvais parce que mes intestins sont tombés. En plus, avec la ventilation, j'ai attrapé des boutons qui sont en fait des caméras microscopiques qui enregistrent tout. »
De référence	Idée délirante dans laquelle le sujet pense que certains éléments de l'environnement posséderaient une signification particulière pour lui, idée dans laquelle le sujet est lui-même la référence	« Le présentateur du journal télévisé s'adresse spécifiquement à moi lorsqu'il annonce qu'un grave accident d'avion a eu lieu hier. »

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome positif

- Idées délirantes
- Hallucinations (75%)
  - Perceptions sans objet
    - psychosensorielles: auditives (50%), visuelles (30%), tactiles (5%), olfactives, cénesthésiques
    - intrapsychiques: voix

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Hallucinations verbales

- Perception de langage non produite par un interlocuteur
- Les causes sont multiples
- Représentent la modalité hallucinatoire la plus fréquente de la schizophrénie
- Se manifestent le plus souvent sous la forme de phrase exprimée à haute voix dans l'environnement du sujet ou l'intimité de sa pensée

13

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Caractérisations des hallucinations verbales

- Le plus souvent, il s'agit de voix qui peuvent s'adresser au sujet à la deuxième personne ou converser entre elles et parler du sujet à la troisième personne.
- Elles sont de tonalités généralement désagréables: trilogie du mépris, de l'injure, de la calomnie (Henri Ey)
- Les voix peuvent être connues ou inconnues (de défunt, de Dieu, du diable)
- Elles peuvent répéter la pensée du sujet (écho de la pensée), commenter ses actes ou encore lui donner des ordres (hallucinations impérieuses)
- Elles peuvent ê entendues par une oreille, par les deux, provenir de près ou de loin, et elles sont clairement localisées dans l'espace.

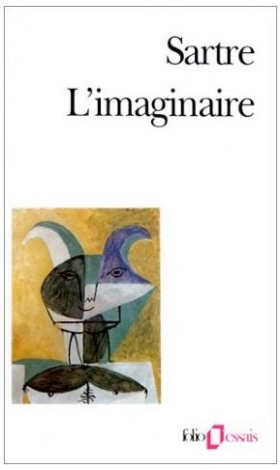
14

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Hallucinations verbales

- Privation sensorielle, dont surdité acquise
- Hallucinations induites par un stress majeur
- Hallucinations lors de l'endormissement (hypnagogiques)

15



16

17

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome négatif

- Au niveau affectif: émoussement des affects
  - absence d'émotions dans l'expression du visage et l'intonation de la voix
  - regard fixe, corps figé, sourire rare
- Au niveau cognitif: pauvreté du discours ou alogie
  - difficulté à converser avec des réponses brèves, évasives, parfois interrompues
- Au niveau comportemental: apragmatisme, aboulie, retrait social

Item 63

18

CARTOGRAPHIE MINIMALE DE LA PSYCHIATRIE

6. Entretien psychiatrique

Langage

Alogie

Pauvreté du discours retrouvé dans le syndrome négatif de la schizophrénie.

G. Scantamburlo - ULiège

DICOSEMIOPSY

19

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome négatif

- Au niveau affectif: émoussement des affects
- Au niveau cognitif: pauvreté du discours ou alogie
- Au niveau comportemental:
  - apragmatisme: incapacité à entreprendre et planifier des actions
  - aboulie: incapacité à mettre en oeuvre une action, marquée par une diminution de la motivation
  - retrait social

G. Scantamburlo - ULiège

Item 63

20

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome de désorganisation

- Perte de l'unité psychique entre idées, affectivité et attitudes
  - Cognitifs
  - Affectifs
  - Comportements

21

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome de désorganisation

- Perte de l'unité psychique entre idées, affectivité et attitudes
  - Cognitifs
    - altération du cours de la pensée
      - *barrage*: brusque interruption du discours
      - *fading*: ralentissement du discours et réduction du volume sonore
    - altération du système logique ou illogisme
    - altérations du langage

22

CARTOGRAPHIE MINIMALE DE LA PSYCHIATRIE

6. Entretien psychiatrique

Langage

Barrage

Brusque suspension du langage dans le cadre du syndrome de désorganisation.

DICOSEMIOPSY

23

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome de désorganisation

- Perte de l'unité psychique entre idées, affectivité et attitudes
  - Cognitifs
    - altérations du langage
      - *néologismes*: nouveaux mots
      - *paralogismes*: nouveaux sens à des mots connus

G. Scantamburlo - ULiège

Item 63

24

CARTOGRAPHIE MINIMALE DE LA PSYCHIATRIE **6. Entretien psychiatrique**

Langage

Néologisme

Invention de nouveaux mots.

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénie: syndrome de désorganisation

- Perte de l'unité psychique entre idées, affectivité et attitudes
  - Désorganisation comportementale: absence de relation entre les différentes parties du corps, pensées et comportements
    - maniérisme gestuel: mauvaise coordination des mouvements
    - parakinésies: décharges motrices imprévisibles
    - syndrome catatonique: *catalepsie* (fléxibilité cireuse des membres avec maintien des attitudes imposées), *négativisme* (attitudes de résistance voire d'opposition), stéréotypies ou *écholalie* (répétition non volontaire de la fin des phrases)

Présentation Contact	Langage Pensées	Perception	Attention Mémoire	Affectivité	Fonctions physiologiques	Comportement	Jugement Insight
Apparence Extravagante Bizarre Incurie	**Dynamique** Logorrhée Tachyphémie Tachypsychie Fuite des idées	**Hallucinations** Intrapsychiques Sensorielles	**Attention** Hypoprosexie Distractibilité Hyperprosexie Hypervigilance	**Emotions** Hyperesthésie Hypoesthésie Peur, colère, anxiété	**Sommeil** Insomnie Hypersomnie Cauchemars Eveils nocturnes	**Evitement**	**Jugement** Diminué
Mimique Hypermimie Hypomimie Amimie Dysmimie	**Dynamique** Alogie, mutisme Bradyphémie Bradypsychie Barrage, fading	**Illusions** Perceptions déformées	**Mémoire épisodique** Remémoration Reviviscences Flashbacks Amnésie	**Emotions** Inadaptées, Discordance idéo-affective, Ambivalence	**Alimentation** Symptômes Anorexie ou Hyperphagie	**Compulsions** rép. Obsessions Rech. Substances	**Jugement** Altéré Pensée illogique, paralogique Abstraction
Activité psychomotrice Agitation Hyperactivité Hyperkinésie	**Forme** Dysprosodie Echolalie Néologisme Paralogisme	**Perceptions sensorielles** Augmentées Diminuées	**Mémoire de travail** Oubli, erreur, difficulté organisation	**Emotions** Craving Anhédonie Hyperhédonie Désinhibition	**Sexualité** Désir, Excitation Augmenté, diminué	**Suicidaire** Recherche moyens létaux	**Insight** Conscience du trouble Adhésion au traitement
Activité psychomotrice Ralentissement Bradykinésie Inadaptée Stéréotypies Akathisie Sursauts	**Idées Délirantes** **Idées Anxieuses** Trauma, AP, obs, souci **Hum. Dépressive** Culpabilité, incurabilité, Honte, regret, Idées suicidaires **Hum. Expansive** Idées de grandeur, optimisme démesuré	**Perceptions dissociées** Déréalisation Dépersonnalisation		**Humeur** Hyperthymie Hypothymie Irritable, labile Aboulie Apragmatisme	**Neurovégétatifs** Signes sympathiques d'Anxiété d'Hyperactivité	**Interpersonnel** Clinophilie, Retrait social Désinhibé, ludisme Hostilité Impulsivité Auto/hétéro agression Conduite à risque Bizarre, immotivé	

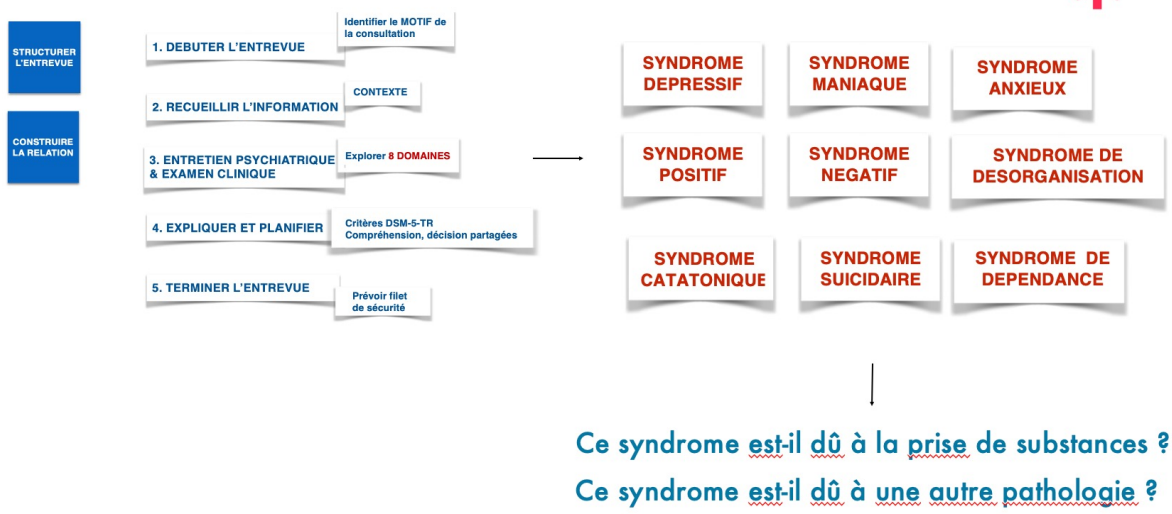
G. Scantamburlo - ULiège

Syndrome positif
Syndrome négatif
Syndrome de désorganisation

27

CARTOGRAPHIE MINIMALE DE LA PSYCHIATRIE

Démarche clinique et diagnostique



Ce syndrome est-il dû à la prise de substances ?

Ce syndrome est-il dû à une autre pathologie ?

G. Scantamburlo - ULiège

28

Schizophrénie selon le DSM-5-TR : 5 critères

A. 2 ou plus parmi les symptômes suivants, chacun devant être présents dans une proportion significative de temps pendant une période d'au moins 1 mois, au moins un des symptômes (1), (2) ou (3) doit être présent:

1. Idées délirantes
2. Hallucinations
3. Discours désorganisé (incohérence)
4. Comportement désorganisé ou catatonique
5. Symptômes négatif (aboulie ou diminution des expression émotionnelles)

B. Altération du fonctionnement dans un domaine majeur (travail, relations interpersonnelles, hygiène personnelle)

C. Des signes continus du trouble persistent depuis au moins 6 mois.

D. Une trouble schizo-affectif, ou dépressif, un trouble bipolaire avec manifestations psychotiques ont été exclus.

E. Le trouble n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre pathologie médicale.

F. S'il existe des ATCD de trouble du spectre de l'autisme, le diagnostic surajouté est posé ssi des symptômes hallucinatoires ou délirants, en plus des autres symptômes nécessaire au diagnostic, sont présents pendant au moins un mois.

G. Scantamburlo - ULiège

29

Trouble psychotique bref selon le DSM-5-TR

A. Présence d'un (ou plus) des symptômes suivants. Au moins un des symptômes (1), (2) ou (3) doit être présent:

1. Idées délirantes
2. Hallucinations
3. Discours désorganisé (incohérence)
4. Comportement désorganisé ou catatonique

N.B.: Ne pas inclure un symptôme s'il s'agit d'une modalité culturellement admise.

B. Au cours d'un épisode, la perturbation persiste au moins 1 jour mais moins d'1 mois, avec retour complet au niveau prémorbide

C. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un trouble dépressif caractérisé, un trouble bipolaire avec manifestations psychotiques ou un autre trouble psychotique, et n'est pas due aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre pathologie médicale.

Spécifier :
Avec facteur(s) de stress marqué(s)
Sans facteur(s) de stress marqué(s)
Avec catatonie
Avec début lors du post-partum

G. Scantamburlo - ULiège

30

Trouble schizophréniforme selon le DSM-5-TR

A. 2 ou plus parmi les symptômes suivants, chacun devant être présents dans une proportion significative de temps pendant une période d'au moins 1 mois,
au moins un des symptômes (1), (2) ou (3) doit être présent:

1. Idées délirantes
2. Hallucinations
3. Discours désorganisé (incohérence)
4. Comportement désorganisé ou catatonique
5. Symptômes négatif (aboulie ou diminution des expression émotionnelles)

B. Un épisode dure au moins 1 mois mais moins de 6 mois, avec retour complet au niveau prémorbide

C. Une trouble schizo-affectif, ou dépressif, ou bipolaire avec manifestations psychotiques ont été exclus.

D. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre pathologie médicale.

G. Scantamburlo - ULiège

31

Trouble schizoaffectif selon le DSM-5-TR

A. Période ininterrompue de maladie pendant laquelle sont présents à la fois un épisode thymique caractérisé (dépressif ou maniaque)et le critère A de la schizophrénie .

N.B.: en cas d'épisode dépressif caractérisé, le critère A1 (humeur dépressive) doit être présent.

B. Idées délirantes ou hallucinations pendant au moins 2 semaines, en dehors d'un épisode thymique

C. Les symptômes de l'épisode thymique sont présents pendant la majeur partie de la durée de la maladie

D. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre pathologie médicale.

Spécifier
Type bipolaire
Type dépressif

G. Scantamburlo - ULiège

32

Trouble délirant selon le DSM-5-TR

A. Présence d'1 (ou plusieurs) idées délirantes pendant une durée d'1 mois ou plus.

B. Le critère A de la schhizophrénie n'est jamais rempli.

N.B. : si des hallucinations sont présentes, elles ne sont pas prééminentes et sont en rapport avec le thème du délire

C. En dehors de l'impact de l'idée (des idées) délirante(s) ou de ses (leurs) ramification(s), il n'y a pas d'altération marquée du fonctionnement ni de singularité ou de bizarreries.

D. Si des épisodes maniaques ou dépressifs sont survenus concomitamment, ils ont été de durée brève.

E. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre pathologie médicale.

Spécifier
Type érotomaniaque
Type mégalomaniaque
Type de jalousie
Type de persécution
Type somatique

G. Scantamburlo - ULiège

33

Alcool
LSD
Amphétamine,
Cocaïne,
Cannabis

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

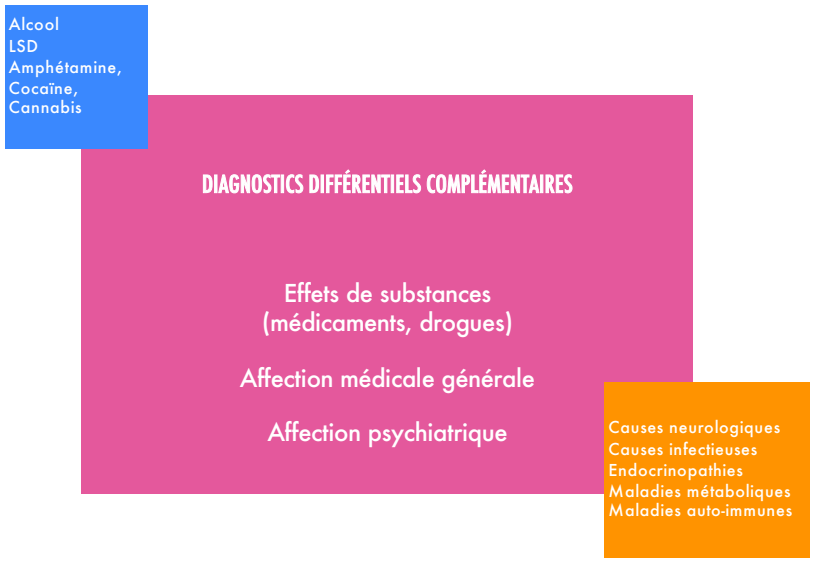
Effets de substances
(médicaments, drogues)

Affection médicale générale

Affection psychiatrique

G. Scantamburlo - ULiège

34

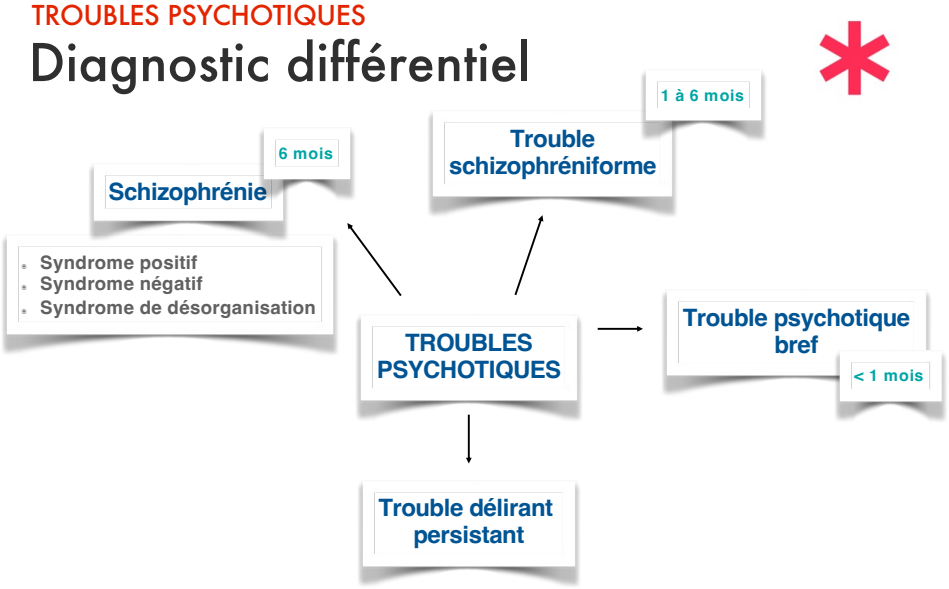


G. Scantamburlo - ULiège

35

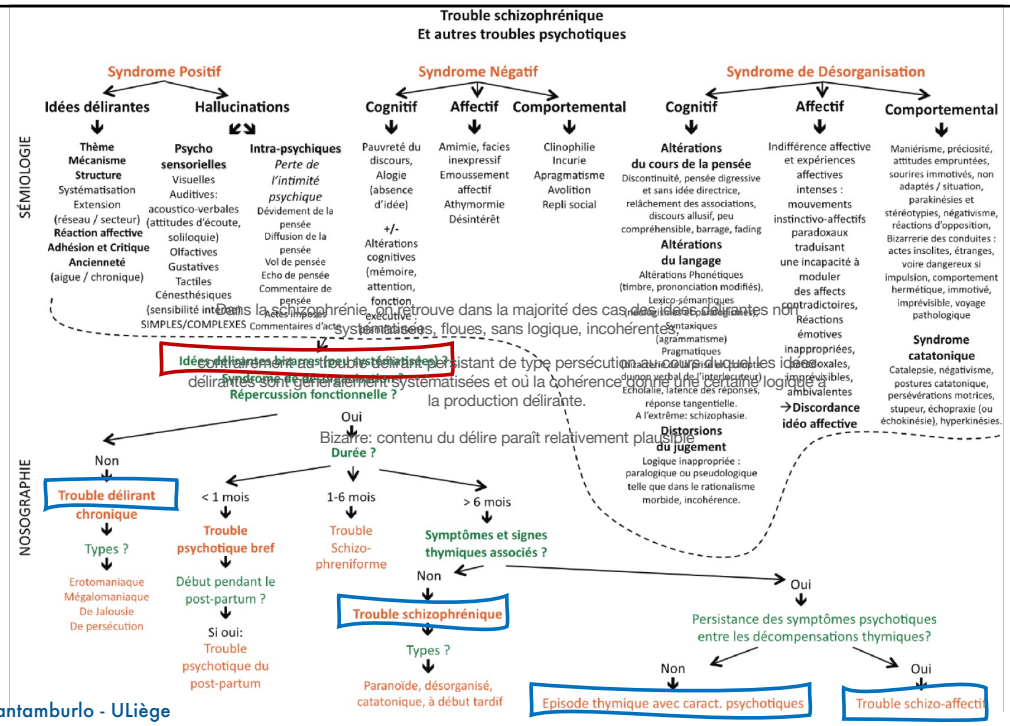
TROUBLES PSYCHOTIQUES

Diagnostic différentiel



G. Scantamburlo - ULiège

36

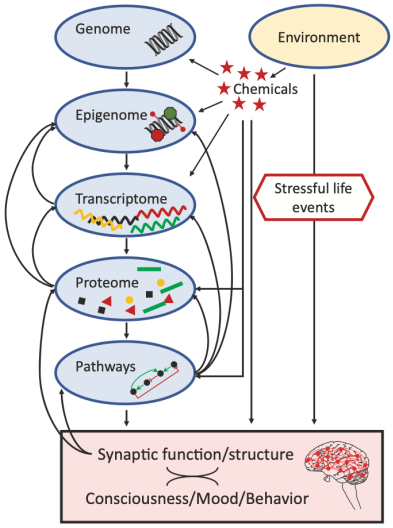


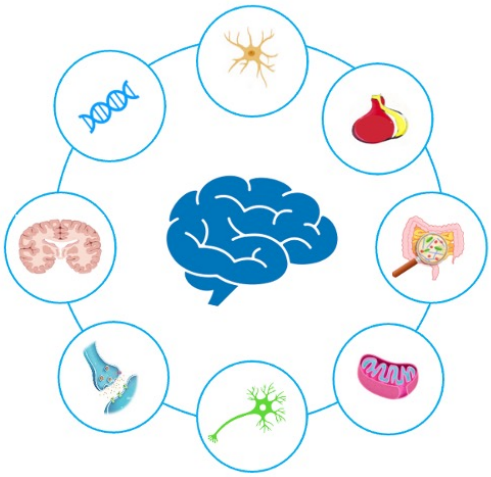
G. Scantamburlo - ULiège

37

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Mécanismes pathophysiologiques





G. Scantamburlo - ULiège

38

TROUBLES PSYCHOTIQUES

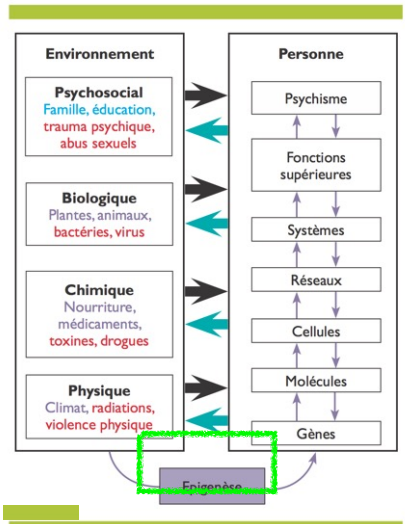


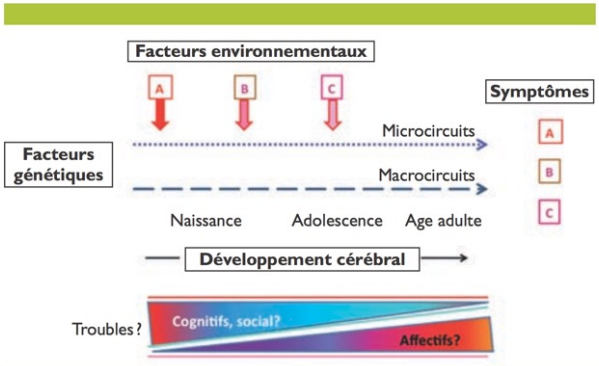
Figure 1. Schéma des interactions entre l'environnement et l'individu à différents niveaux d'organisation

G. Scantamburlo - ULiège

39

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Hypothèse neurodéveloppementale



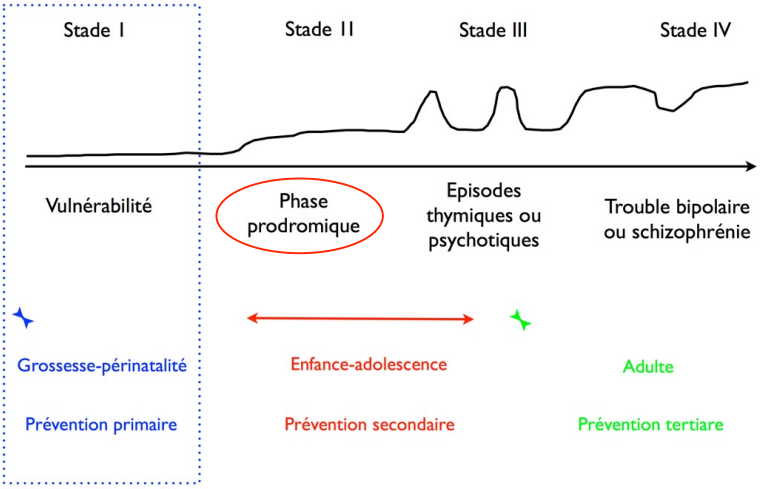
Rôle de la phase du développement dans laquelle les impacts environnementaux se produisent

G. Scantamburlo - ULiège

40

TROUBLES PSYCHOTIQUES

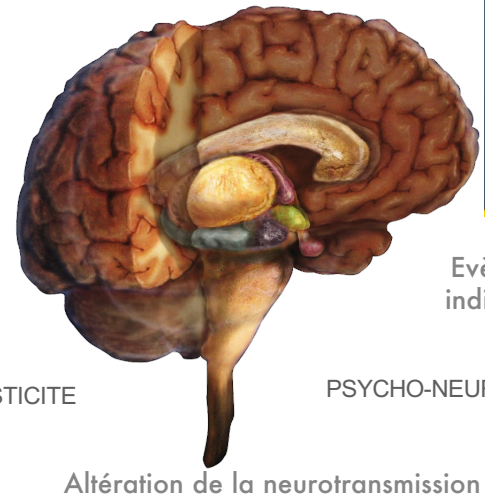
Perspective diachronique



G. Scantamburlo - ULiège

41

Facteurs génétiques



Stresseurs

Evènements, situations, individus, commentaires

NEUROPLASTICITE

PSYCHO-NEURO-IMMUNOLOGIE

Altération de la neurotransmission et de l'immunité

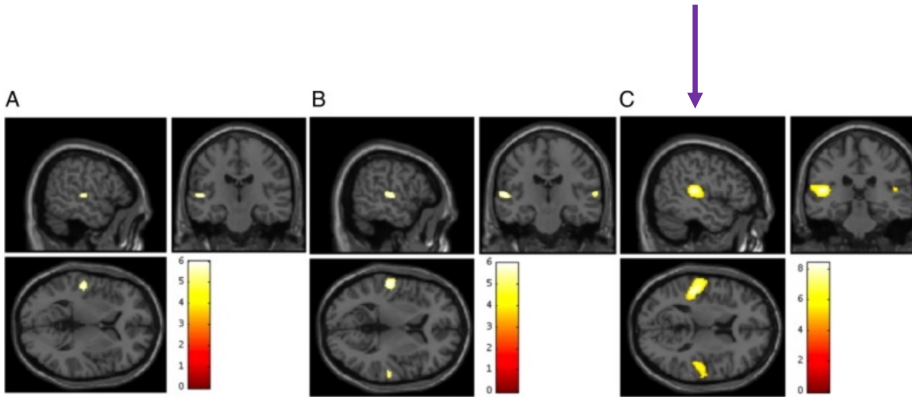
G. Scantamburlo - ULiège

42

43

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Activations cérébrales durant les hallucinations

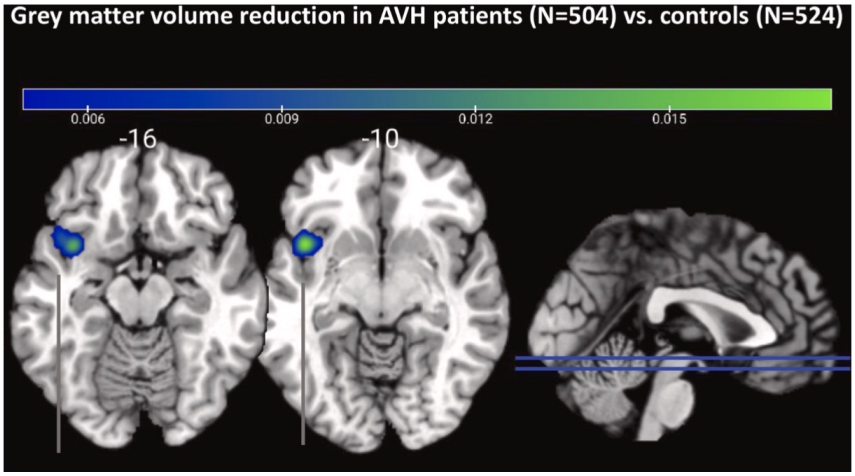


G. Scantamburlo - ULiège

44

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Réduction de substance grise

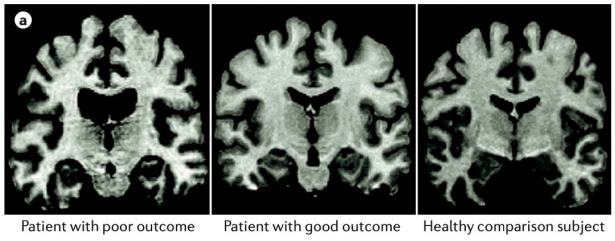


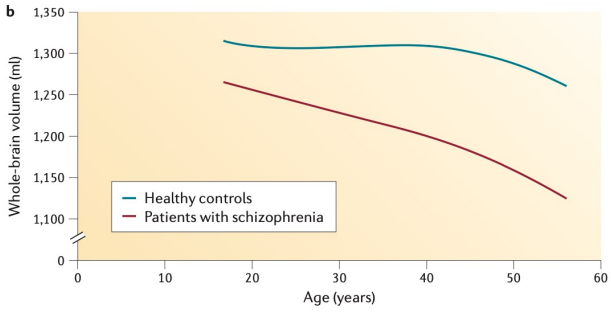
G. Scantamburlo - ULiège

45

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Modification du volume cérébral



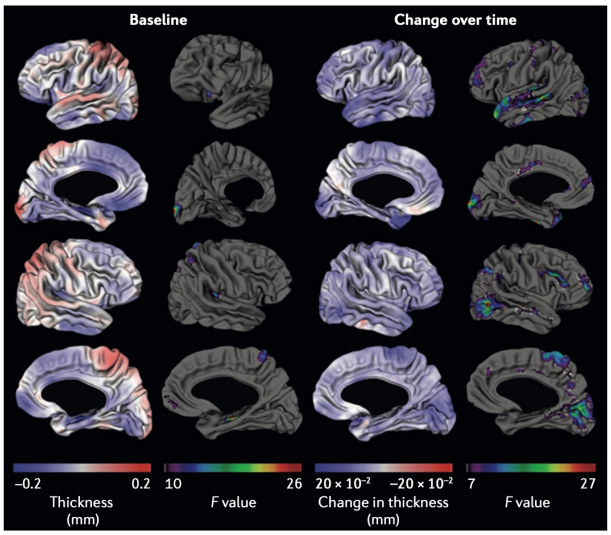


G. Scantamburlo - ULiège

46

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Modification de l'épaisseur corticale

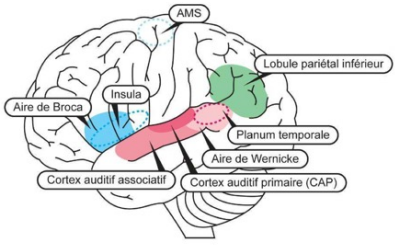


47

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Un syndrome de déconnexion ?

- Modulation défaillante dans le réseau fronto-temporal
- Dysfonctionnement de la parole intérieure qui serait attribuée à un agent externe

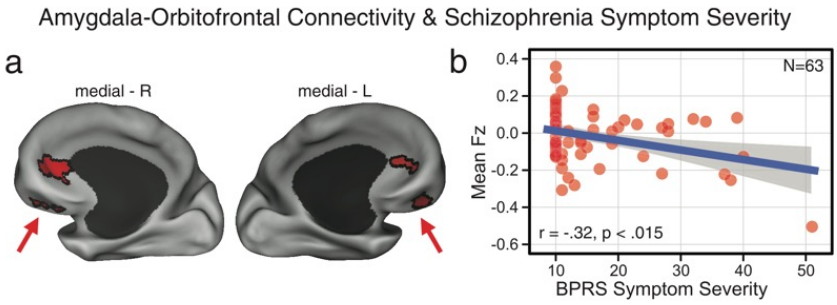


Localisation des régions impliquées dans le traitement du langage. Les régions en pointillé sont situés à l'intérieur des gyri et pas à la surface.

48

TROUBLES PSYCHOTIQUES

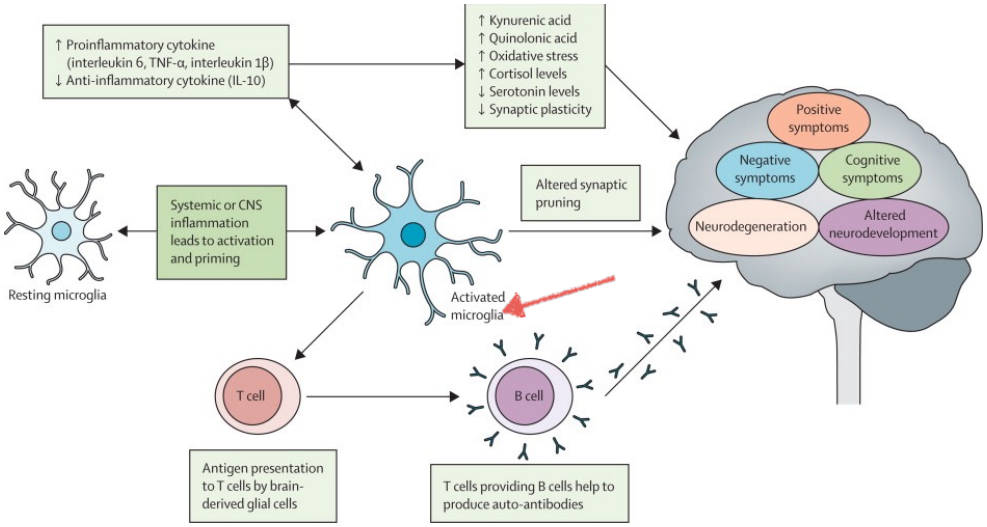
Anomalies de la connectivité



49

Inflammation and immunity in schizophrenia: implications for pathophysiology and treatment

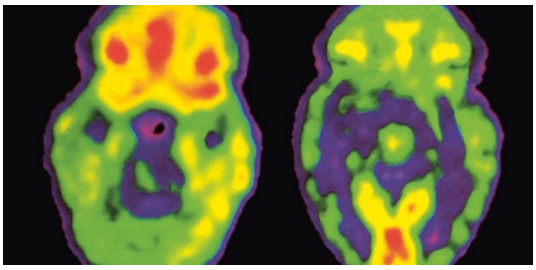
Golam M Khandaker*, Lesley Cousins*, Julia Deakin, Belinda R Lennox, Robert Yolken, Peter B Jones



50

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Impact du stress oxydatif



Origine génétique
ou environnementale

Déficit du système anti-oxydant

Lésions neuronales

Altération de la connectivité

G. Scantamburlo - ULiège

51

TROUBLES PSYCHOTIQUES

3 voies de neurotransmetteurs

Dopamine Theory
Hyperactive dopamine at D2 receptors in the mesolimbic pathway

Glutamate Theory
NMDA receptor hypofunction

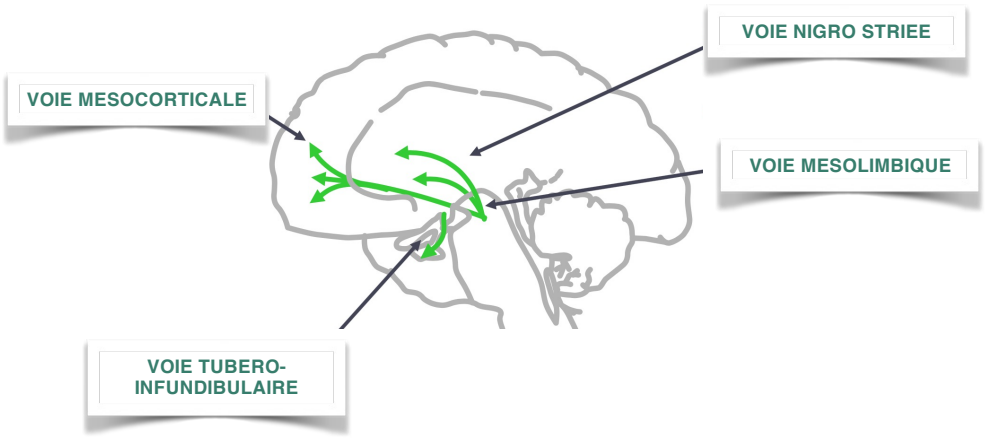
Serotonin Theory
5HT2A receptor hyperfunction in the cortex

G. Scantamburlo - ULiège

52

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Hypothèse des voies dopaminergiques



G. Scantamburlo - ULiège

53

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Schizophrénies: Traitements

Hospitalisation si

- Episode aigu avec troubles du comportements
- Risque suicidaire avec mise en danger
- Risque hétéro-agressif

Traitements pharmacologiques

- Antipsychotiques

Traitements non-pharmacologiques

- ECT
- Education thérapeutique
- Psychothérapie: TCC
- Remédiation cognitive
- Réadaption psycho-sociale

Prise en charge des comorbidités

Item 74

G. Scantamburlo - ULiège

54

PSYCHOTROPES

ANTIPSYCHOTIQUES

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

Indications

- Troubles psychotiques
- Troubles de l'humeur
- Prévention des rechutes du trouble bipolaire
- Traitement de courte durée de l'anxiété, TOC résistant, insomnies réfractaires

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Objectifs du traitement

- Alléger les symptômes
- Prévenir les rechutes
- Traitements des pathologies comorbides
- Aborder les problèmes psychosociaux

TROUBLES PSYCHOTIQUES

Principes du traitement pharmacologique

- Remédier aux symptômes positifs
  - diminuer l'hyperactivité dopaminergique de la voie mésolimbique
- Remédier aux symptômes négatifs et cognitifs
  - activer l'hypoactivité dopaminergique de la voie mésocorticale

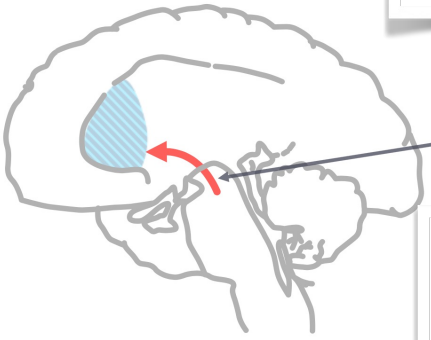
G. Scantamburlo - ULiège

57

PSYCHOTROPES

ANTIPSYCHOTIQUES

Bases biologiques de la schizophrénie: les 4 voies dopaminergiques



Du tronc cérébral (tegmentum ventral) vers le système limbique (noyau accumbens)

VOIE MESOLIMBIQUE

Hyperactivité mésolimbique

responsable des SYMPTÔMES POSITIFS (délires, hallucinations) et agressifs

G. Scantamburlo - ULiège E. Hermans - farm.ulc.ac.be Ngo-Minh

58

PSYCHOTROPES

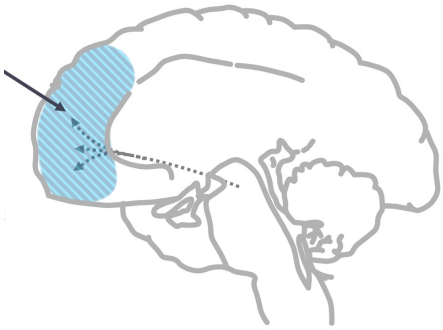
ANTIPSYCHOTIQUES

Bases biologiques de la schizophrénie: les 4 voies dopaminergiques

VOIE MESOCORTICALE

Hypoactivité mésocorticale

(liée soit à un processus dégénératif soit à une déficience 5-HT en amont) responsable des SYMPTÔMES NEGATIFS (retrait social, anhédonie, apathie, indifférence) et COGNITFS



Du tronc cérébral (tegmentum ventral) vers le cortex cérébral

G. Scantamburlo - ULiège

E. Hermans - farm.ulc.ac.be

59

PSYCHOTROPES

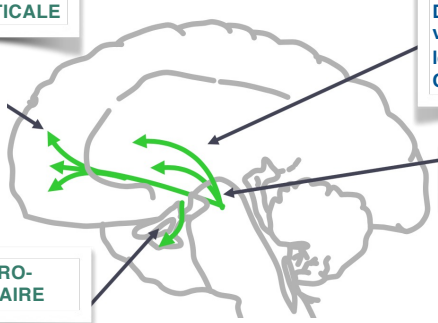
ANTIPSYCHOTIQUES

Bases biologiques de la schizophrénie: les 4 voies dopaminergiques

VOIE NIGRO STRIEE

VOIE MESOCORTICALE

Du tronc cérébral (substance noire) vers les ganglions de la base et le striatum
Contrôle de la motricité



VOIE MESOLIMBIQUE

VOIE TUBERO-INFUNDIBULAIRE

G. Scantamburlo - ULiège

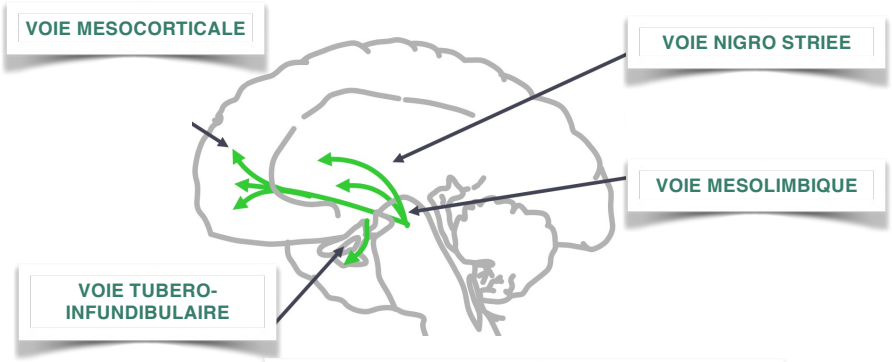
E. Hermans - farm.ulc.ac.be

60

PSYCHOTROPES

ANTIPSYCHOTIQUES

Bases biologiques de la schizophrénie: les 4 voies dopaminergiques



Du l'hypothalamus vers l'hypophyse
Contrôle inhibiteur de la production de PROLACTINE

G. Scantamburlo - ULiège

E. Hermans - farm.ulc.ac.be

61

PSYCHOTROPES

ANTIPSYCHOTIQUES

Principales molécules

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

Classe (à titre indicatif)		Molécule	Per os	IM	IM Retard
Antipsychotiques typiques ou de première génération	Phénothiazines	Chlorpromazine (Largactil®)	X	X	
		Cyamémazine (Tercian®)	X	X	
		Alimémazine (Théralène®)	X		
		Lévomépromazine (Nozinan®)	X	X	
		Pipotiazine (Piportil®)	X		X
		Propericiazine (Neuleptil®)	X		
	Butyrophénones	Halopéridol (Haldol®)	X	X	X
		Pipampérone (Dipipéron®)	X		
		Dropéridol (Droleptan®)		X	
	Thio-xanthènes	Flupentixol (Fluanxol®)	X		X
		Zuclopenthixol (Clopixol®)	X	SP	X
	Benzamides	Sulpiride (Dogmatil®)	X		
		Tiapride (Tiapridal®)	X		

En cas d'urgence

G. Scantamburlo - ULiège

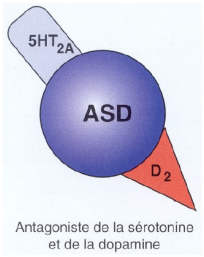
Item 74

62

ANTIPSYCHOTIQUES

Les neuroleptiques atypiques

clozapine
rispéridone
olanzapine
quétiapine
(clotiapine)



Antagoniste de la sérotonine et de la dopamine

Caractéristiques :

Biochimiques : ASD - Antagoniste mixte sérotonine (récepteurs 5HT2A) et dopamine (récepteur D2)

Cliniques : traitent les symptômes positifs sans provoquer d'effets extrapyramidaux

63

PSYCHOTROPES

Principales molécules

ANTIPSYCHOTIQUES

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

	Classe (à titre indicatif)	Molécule	Per os	IM	IM Retard
Antipsychotiques atypiques ou de seconde génération		Amisulpride (Solian®)	X	X	
	Dibenzo-oxazépines	Loxapine (Loxapac®)	X	X	
		Olanzapine (Zyprexa®)	X	X	X
	Dibenzo-diazépines	Clozapine (Leponex®)	X		
		Quetiapine (Xeroquel®)	X		
	Benzisoxazoles	Risperidone (Risperdal®)	X		X
		Paliperidone (Xeplion®)			X
	Quilonolones	Aripiprazole (Abilify®)	X	X	X

64

PSYCHOTROPES

Traitement d'attaque

ANTIPSYCHOTIQUES

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

Au moment de l'initiation (traitement d'attaque) :

* la molécule est choisie en fonction de l'indication, de la symptomatologie prédominante, des antécédents de traitement par antipsychotique (en termes d'efficacité et de tolérance), des contre-indications, de l'habitude du prescripteur et des préférences exprimées par le patient ;
* les doses sont rapidement progressives ;
* la posologie est ajustée en fonction de l'efficacité et de la tolérance du traitement.

Efficacité en 4 à 6 semaines sur les symptômes positifs

65

PSYCHOTROPES

Traitement de fond

ANTIPSYCHOTIQUES

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

Le choix de l'antipsychotique est fait en fonction de l'efficacité, de la tolérance et de l'observance des traitements déjà reçus. Les antipsychotiques atypiques sont recommandés en première intention :

* amilsulpride (Solian),
* aripiprazole (Abilify),
* olanzapine (Zyprexa),
* quétiapine (Seroquel),
* rispéridone (Risperdal).

L'antipsychotique choisi doit être approprié à la phase aiguë et au long terme. Il est prescrit à la posologie la plus efficace. Un autre traitement neuroleptique peut être proposé en deuxième intention.

Classiquement, lorsque le patient a résisté à deux antipsychotiques atypiques à posologie et durée efficaces : la clozapine (Leponex) doit être envisagée (cf. Item 72). Dans les situations où l'observance est difficile, certains antipsychotiques d'action prolongée ou « retard » existent sous forme intra-musculaire permettant selon les molécules une injection tous les 15 jours ou 3 semaines [par ex., risperidone (Risperdal Consta, Xeplion), olanzapine (Zypadhera)] (cf. Item 72).

66

PSYCHOTROPES

Traitement de fond: repère

ANTIPSYCHOTIQUES

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

- Après un épisode psychotique bref unique: maintien du traitement au moins 2 ans
- Après un second épisode: au moins 5 ans
- Si diminution: de manière progressive

G. Scantamburlo - ULiège

67

Profil d'effets indésirables, notamment métaboliques, des antipsychotiques atypiques[38-43]

Antipsychotique	SEP*	Allongement de l'intervalle QTc	Sédation	Dysfonction sexuelle	Hyper-lipidémie	Gain pondéral	Risque de diabète	Dyslipidémies
Aripiprazole								
Olanzapine								
Quétiapine								
Rispéridone								

* SEP : Symptômes extrapyramidaux

Risque neutre-faible | Risque modéré | Risque élevé

68

69

PSYCHOTROPES

Surveillance

ANTIPSYCHOTIQUES

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

	Avant le traitement	1er mois	3e mois	Une fois par trimestre	Une fois par an	Une fois tous les 5 ans
Poids et IMC	+	+	+	+		
Périmètre abdominal	+				+	
Glycémie à jeun	+		+		+	
Bilan lipidique	+		+			+
Tension artérielle	+		+		+	

Tableau 4. Surveillance clinique et paraclinique d'un patient traité par antipsychotiques.

Une complication rare mais potentiellement mortelle des neuroleptiques doit impérativement être connue : le syndrome malin des neuroleptiques (cf. Item 72).

G. Scantamburlo - ULiège

70

PSYCHOTROPES

ANTIPSYCHOTIQUES

Syndrome neuroleptique malin: rare mais grave

URGENCE DIAGNOSITQUE ET THERAPEUTIQUE

- Décrit avec la plupart des molécules
- Engage le pronostic vital

71

PSYCHOTROPES

ANTIPSYCHOTIQUES

Syndrome neuroleptique malin: rare mais grave

URGENCE DIAGNOSITQUE ET THERAPEUTIQUE

- Une fièvre avec un syndrome confusionnel doit faire évoquer ce syndrome
- Une fièvre inexpliquée chez un patient traiter doit faire suspendre le traitement

72

PSYCHOTROPES

ANTIPSYCHOTIQUES

Syndrome neuroleptique malin: rare mais grave

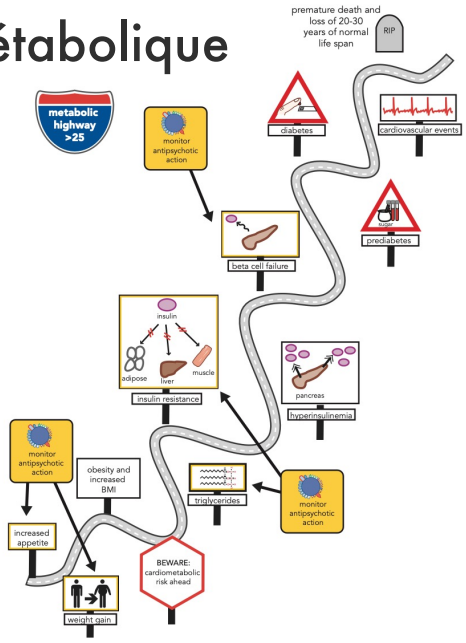
- Mode de début rapidement progressif
  - Hyperthermie (40-41°) ou hypothermie (36°)
  - Rigidité extrapyramidale
  - Sueurs profuses
  - Tachycardies
  - Hypotension artérielle
  - Troubles de la vigilance
  - Troubles cardiorespiratoires
  - Possibles convulsions

G. Scantamburlo - ULiège

73

PSYCHOTROPES

Monitoring Métabolique



G. Scantamburlo - ULiège

82